D.保守治疗后，病情急剧恶化

11. 2018N98-99 A 男性，39 岁，饱餐饮酒后出现上腹部持续性疼痛伴恶心呕吐 6 小时入院。查体：T 37℃，P 110 次/分，BP 136/86mmHg，腹部平坦，中上腹有压痛，轻度肌紧张，肠鸣音正常。化验血 WBC 12×10^9/L，N 78%，血清淀粉酶 2130U/L。拟诊急性胰腺炎。入院后的腹部增强 CT 检查提示：胰腺增大，密度不均，边界模糊，胰周有中等量渗出液，胰腺体尾部片状低密度影，强化不均匀。
坏死 坏死

98.首选的治疗方法是

A.手术清除坏死组织及引流
B.穿刺置管引流积液
C.胰腺体尾部切除术
D.全身支持保守治疗

	轻症	中重症	重症	危重
胰液跑来跑去 器官衰竭（依据呼吸、循环、肾功能评价）	无	≤48 小时 一过性	>48 小时	>48 小时
	和	和/或	或	和
胰腺坏死（CT）	无	无菌性	感染性	感染性

99.对判断患者的预后最有价值的化验结果是

该患者临床分型是 B
A.轻症
B.中重症
C.重症
D.危重

A.血清淀粉酶升高 3 倍以上
B.血清钙降至 2.0mmol/L 以下
C.血清脂肪酶升高
D.早期血糖升高 应激

12. 2022N160 X 血清淀粉酶检验值诊断急性胰腺炎的意义，正确的有

A.血淀粉酶值持续升高，不代表胰腺炎持续加重 定性(诊断)不定量(严重程度)
B.血淀粉酶值下降后又升高，说明病情有反复
C.血淀粉酶值不高，可排除胰腺炎 重症胰腺炎血淀粉酶可升高/正常/下降
D.血淀粉酶值愈高，诊断正确率也愈高

13. 2023N96-97 A 男性，50 岁。饮酒后上腹部疼痛伴恶心呕吐 6 小时就诊。既往体健。查体：T 37 度，P 80 次/分，BP 130/80mmHg。皮肤巩膜无黄染，上腹部压痛，无反跳痛及肌紧张。化验：血 WBC 11×10^9/L，血淀粉酶 1000U/L。

96.最可能的诊断是

A.急性胆管炎
B.急性胃炎
C.急性胰腺炎
D.上消化道穿孔

97.下列治疗措施中，不恰当的是

A.禁食、补液
B.使用抗生素
C.使用生长抑素
D.常用吗啡止痛 加重oddi括约肌痉挛 可用哌替啶

14. 2025N160 X 急性胰腺炎的手术适应证有

适合做手术没有否认内科处理
e.g 假性囊肿达6cm或造成类似于幽门梗阻的症状 先保守等6-8w囊壁成熟就可以手术

A.合并腹腔大出血
B.胰腺及胰周坏死组织继发感染
C.继发肠道穿孔
D.合并胆管结石

答案：11-14 DB ABD CD ABCD